镜像丘脑性失语症1例

张梦迪

【摘要】 交叉性失语中镜像失语症指右侧大脑半球特定区域受损时，所产生的失语症状与左侧大脑半球同一部位受损引起的失语症状相似。文章报道1例右利手老年男性患者，因右侧丘脑出血导致其出现镜像丘脑性失语症，评估后对患者进行针对性的言语训练、认知训练、针灸治疗等，经3个月康复治疗后，患者认知与交流能力明显进步。

【关键词】 丘脑出血；镜像失语症；丘脑性失语症；失语症治疗
DOI：10.19542/j.cnki.1006-5180.2503-534

交叉性失语是一种临床中少见的失语症，主要指右利手者右侧大脑半球损伤导致的失语表现[1]。丘脑性失语症通常由左半球的皮质下语言网络病变引起，而右丘脑损伤后出现失语症症状临床罕见。我科2024年7月收治1例镜像丘脑性失语症患者，对其进行系统性的言语康复治疗，患者言语和认知障碍有所改善，现将其诊治情况报道如下。

1 病历摘要

1.1 一般资料

患者男，68岁，高中文化，母语汉语，右利手。因“左侧肢体不灵伴言语不利1月余”于2024年7月2日来我院进行康复治疗。现病史：右侧脑出血引流术后1个月，左侧肢体活动不便、偏身感觉障碍伴言语不利。既往史：糖尿病病史4年，高血压病史1年。CT检查：右侧丘脑见高密度灶，第三、第四双侧脑室见高密度，右顶叶斑片状高密度。中医诊断：中风·风火上扰证。西医诊断：脑出血恢复期；2型糖尿病；高血压3级（极高危）。入院后第1天，物理治疗师发现患者存在指令理解障碍和“答非所问”，建议患者在言语治疗师的介入下行系统的言语评估与治疗。

1.2 康复评估（7月2日）

① 简易精神状况检查（MMSE）评估患者认知功能，总分30分，评定时间5～10 min，按照认知障碍划分的标准，一般文盲≤17分，小学文化≤20分，中学文化≤24分。患者评分4分。② 汉语失语症成套测验进行患者失语症的诊断与评估，内容包括会话、理解、复述、命名、阅读、书写、结构与视空间、运用与运算等项目，采用统一指导语、评分标准及图片文字。患者听理解、复述较好，阅读和书写不能完成。③ 波士顿诊断性失语检查评估患者失语症等级，严重程度分为0～5级，等级越高言语功能越好。患者评定为1级，言语交流中有不连续的言语表达，但大部分需要听者去推测。④ 日常生活交流能力检查评估患者语言交流能力，评分包括22项，共34个亚项，每一亚项0～4分，总分136分，分值越高交流能力越好。患者评分20分。言语特点：自发言语少、声音小，复述较好，复杂指令可复述不能执行，找词困难，错语（把“猫”说成“鱼”），持续现象（随机连续3张图片都说成“鱼”），命名障碍明显。失语症诊断：镜像丘脑性失语症。

1.3 康复方案

1.3.1 言语训练（每周6次，每次30 min）

① 许尔失语症刺激疗法：对损害的语言符号系统，应用强的、控制下的听觉刺激及多途径的刺激，最大限度地促进失语症患者的语言重建和恢复。听理解训练：听词指图、听语记忆广度训练、回答是否问题和执行口头指令；口头表达训练：复述和命名；阅读训练：图字匹配和执行简单文字指令；书写训练：临摹简单图形、抄写数字和文字、听写。② 语义特征分析法：对语言素材的语义特征进行分析，利用患者尚存的语义知识系统进行训练，进而改善患者的命名能力。按照操作流程，引导患者遵循六类特征（类别、动作、使用、属性、方位和联想），寻找目标词。③ 交流促进法：强调治疗师与患者以同等的交谈地位收发消息，将一叠卡片正面朝下扣在桌上，治疗师与患者交替摸卡，且不让对方看见自己手中卡片的内容，利用描述语、手势、书面语、绘画等表达方式将信息传给对方。接收者通过反复确认、猜测质问等方

作者单位：271500 山东东平县人民医院疼痛康复科
通信作者：张梦迪，Email：183863584@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

式进行适当的反馈。当患者具备一定命名能力后，开始应用此方法。④ 功能性交流治疗：介绍自己及家庭成员，住址和电话号码，职业和兴趣爱好，喜欢的食物、电影和电视剧，模拟点菜、购物和打车等。

1.3.2 认知训练（每周6次，每次30min）

利用计算机认知评定和康复训练系统，此系统包括认知评估和训练两大部分。训练内容包括注意、记忆、知觉、单侧忽略、思维和计算。

1.3.3 针灸治疗（每周6次，每次30min）

基于“标本根结”理论[2]，主穴选取哑门、三阴交、通里和廉泉，患者属风火上扰证，加太冲、太溪、风池、肝俞。手法：哑门行捻转补法，廉泉行捻转泻法，余行平补平泻。

1.3.4 家庭治疗

对患者家属进行言语康复宣教，布置居家言语康复作业。如平板游戏、读报、抄写数字等，营造良好的家庭康复氛围，建立病后的生活模式，尽可能恢复患者的社会功能。

1.4 康复结局（9月29日）

经3个月康复治疗，患者MMSE评分由4分提升至21分，效果明显。患者波士顿诊断性失语检查失语症等级由1级提升至3级，几乎可进行所有的日常交流，偶尔需要听者去猜测。汉语失语症测验（表1）显示听理解、复述、命名、抄写、阅读能力均有明显提升，但执行复杂指令、听写、描写、绘图和计算能力进步不明显，可能与这些方面训练强度小有关。日常生活交流能力评分由20分提高至86分，实现了日常独立交流，有利于患者回归家庭和社会。

2 讨论

交叉性失语的诊断标准：失语症的表现；明确的右脑半球损伤；左侧大脑半球结构完整；家族成员无左利手；无童年期脑损伤病史。本例患者满足上述诊断要求，可诊断为交叉性失语。交叉性失语主要分为镜像失语症与非镜像失语症。镜像失语症指右侧大脑半球特定区域受损时，所产生的失语症状与左侧大脑半球同一部位受损引起的失语症状相似。非镜像失语症指右侧大脑半球病变导致的失语症类型，与左侧大脑半球同一部位受损引起的失语症类型不同。本例患者属于镜像失语症。

丘脑在语义与语法加工中起到重要作用。从解剖学基础分析丘脑病变与语言障碍的关系，椎体外系传入丘脑的纤维受损，造成音量减小；腹前核投射到辅助运动区、眶额皮质和导叶前皮质的纤维受损，影响边缘系统活动，造成词汇提取障碍，表现自发性语言减少、命名障碍、词语性错语、新语、杂乱语、找词困难；腹前核接受中脑上行网状系统的纤维，并投射至皮质和苍白球，这些纤维受损时造成语言自我调节能力下降、警戒缺陷，出现语义性错语、持续症；腹前核对Broca区具有调节和驱动作用，若这一相互连接发生中断，会通过经上纵束进一步影响Wernicke区，导致不同程度的理解障碍；腹外侧核发出纤维至中央前回下1/3，即口颊发音器官代表区，与Broca区有纤维连接，对皮质语言中枢有唤起作用，LIU等[3]的研究证实枕核与颞叶及顶颞枕叶交界区的第三语言中枢有纤维联系，参与语义的处理，TIEDT等[4]研究发现背内侧核与测试语义与语法规则有关。丘脑性失语症的主要特点是表情冷淡、声音小、语调低、自发言语减少、启动迟缓，轻度理解障碍、复述较好，找词困难、伴有错语、新语，明显命名障碍，不同程度的阅读和书写障碍。本例患者符合以上语言特点，且CT证实丘脑出血，可诊断为丘脑性失语症。

治疗前患者存在双侧手指失认、肢体左右定向障碍、书写不能、计算不能，符合格斯特曼综合征表现，提示优势半球顶叶角回病变，患者右侧大脑可能为优势半球。治疗1个月后患者手指失认、左右失认症状消失，遗留失写和失算。治疗3个月患者能抄写较好，其次听写，不能完成看图书写。根据语言加工模型[5]：抄写可从字形输入词典到字形输出词典；听写可从语音输入词典到语音输出词典，再到字形输出

（下转第77页）

表1 汉语失语症检查结果 （%）

项 目	治疗前	治疗后	项 目	治疗前	治疗后	项 目	治疗前	治疗后
听理解			阅 读			书 写		
是否题	53	55	视 读	0	80	姓名地址	0	30
听辨认	74	93	听字辨认	0	90	抄 写	0	100
口头指令	30	51	字画匹配朗读	0	90	听 写	0	44
口语表达			字画匹配理解	0	100	系列读写	0	90
复 述	85	90	读指令执行朗读	0	20	看图书写	0	0
词命名	0	93	读指令执行理解	0	80	自发书写	0	0
反应命名	0	100	填 空	0	93			
颜色命名	50	100						

中国知网 https://www.cnki.net

[3] 彭碧辉，王冠群，曾炜美，等．太乙神针治疗背肌筋膜炎的临床疗效：随机对照试验[J]．中国针灸，2024，44（11）：1254.
[4] 李思明，王颖，陈兴娟，等．疼痛散中药火灸治疗腰背肌筋膜炎临床疗效评价[J]．河北中医，2023，45（10）：1623.
[5] 王敏，董宝强．经筋灸法治疗腰背肌筋膜炎随机对照研究[J]．中医药临床杂志，2020，32（5）：959.
[6] 石岩殊．天灸治疗腰背肌筋膜炎临床研究[J]．亚太传统医药，2016，12（10）：103.
[7] 张英，李晶晶，康明非．热敏灸与辨证穴位灸治疗背肌筋膜炎临床随机对照观察[J]．针灸临床杂志，2017，33（3）：40.
[8] 张淑君，杨蕾，李景新，等．围刺针法联合灸法治疗背肌筋膜炎1例医案举隅[J]．中医研究，2018，31（8）：62.
[9] 邝碧瑶．浮针结合艾灸治疗风寒湿型腰背肌筋膜炎的临床研究[D]．广州：广州中医药大学，2020.
[10] 张春霞，张雪松，郭莹莹，等．药物铺灸联合针刺治疗腰背肌筋膜炎60例疗效观察[J]．按摩与康复医学，2021，12（8）：6.
[11] 马力颖，宫树丰，战军林，等．围刺法结合热敏灸治疗背肌筋膜炎的临床观察[J]．中国民间疗法，2021，29（18）：49.
[12] 邹美英，梁永信，邱天明．督灸配合放血疗法治疗背肌筋膜炎的疗效研究[J]．内蒙古中医药，2018，37（11）：76.
[13] 刘雪珂，李梦，刘维，等．刺络放血结合艾灸法治疗腰背肌筋膜炎[J]．长春中医药大学学报，2019，35（2）：280.
[14] 郑荣林．酒醋疗配合雷火灸治疗颈肩肌筋膜炎30例临床观察[J]．医学食疗与健康，2020，18（18）：40.
[15] 王飞，曾祥林，蒋伟伦．艾灸结合葛根汤加减治疗项背肌筋膜炎临床研究[J]．实用中医药杂志，2019，35（8）：932.
[16] 屈庆，李鹏，王睿，等．平衡罐结合督脉灸在寒湿痹阻型腰背肌筋膜炎中的应用观察[J]．浙江中医杂志，2023，58（7）：526.
[17] 秦后伟．艾灸治疗腰背肌筋膜炎临床观察[J]．光明中医，2020，35（16）：2525.
[18] 王艳，姜天鑫，胡林龙，等．针刺、艾盒灸联合筋伤膏治疗腰背肌筋膜炎32例临床观察[J]．甘肃中医药大学学报，2021，38（1）：74.
[19] 凌春生．穴位埋线结合督脉灸治疗腰背肌筋膜炎疗效观察[J]．实用中医药杂志，2021，37（7）：1215.
[20] 陈思思，宗志涛，余杰为．针刺配合铺灸治疗腰背肌筋膜炎对患者日常生活能力的影响[J]．中国医学创新，2021，18（23）：97.
[21] 赵春梅，管遵惠．管氏飞翅三穴配合热敏灸、拔罐治疗背肌筋膜炎32例的临床观察[J]．中国民间疗法，2021，29（18）：36.

（收稿：2025-02-17）
（本文编辑：蔡昊然）

（上接第41页）

词典，两者均可不涉及语义系统，即无需理解词语的具体含义。看图书写中看到的图画直接激活语义系统，进而激活字形输出词典。患者右侧丘脑损伤造成语义加工障碍，故对看图书写的影响最明显，依次是听写和抄写。书写中出现笔画遗漏（如“绿”写成“录”）、部分代替（“匙”中的“是”写成“昊”）和部分完成（“树”中的“寸”少一点）等构字障碍。患者复述能力保留，命名障碍严重，可能与右侧大脑受损后语义加工障碍有关。词典结构模型中，语音可直接通过声音-语音转换到语音输出缓冲，不经过语义系统分析；而图画需要视觉分析后直接经语义系统再到语音输出词典，语义系统受损后，词汇的提取困难，进而产生命名障碍、错语、新语等。

基层康复治疗师平时接触此类失语症案例较少，应结合镜像丘脑性失语症的语言特点和影像学检查（证实丘脑病变）明确诊断，根据患者功能恢复情况调整治疗方案，注重结合现代康复与传统医学，方能在资源有限条件下实现疗效最大化。

参 考 文 献

[1] 贾伟丽，刘琪，李思奇，等．交叉性失语的研究进展[J]．中国卒中杂志，2019，14（10）：1066.
[2] 于清鹏，何圣三．基于“标本根结”理论的针刺疗法联合Schuell刺激疗法治疗卒中后丘脑性失语的疗效评价[J]．河北中医，2018，40（4）：608.
[3] LIU J，CUI Z，LI L，et al. Local and whole-network topologies reveal that pulvinar and semantic hub interactions correlate with picture vocabulary[J]. Neuroreport，2020，31（8）：590.
[4] TIEDT H O，EHLEN F，KRUGEL L K，et al. Subcortical roles in lexical task processing：Inferences from thalamic and subthalamic event-related potentials[J]. Hum Brain Mapp，2017，38（1）：370.
[5] 汪洁，陈滟，吴东宇，等．经颅直流电刺激对失写症书写功能的影响[J]．中国康复医学杂志，2011（12）：1112.

（收稿：2025-03-26）
（本文编辑：张戈薇 白兰芳）

中国知网 https://www.cnki.net